BÁO CÁO THỰC HIỆN
KHẢO SÁT NHẬN DIỆN CHÍNH XÁC NGƯỜI BỆNH
(BÁO CÁO QUÝ IV – CÁC KHOA NỘI VÀ NGOẠI TRÚ)

1. Thông tin chung

Đặc điểm		N	Tỷ lệ (%)
Tuổi	> 18 tuổi	187	98,4%
Giới tính	Nữ	106	55,8%
	Nam	84	44,2%
Khoa điều trị	Các khoa lâm sàng	190	100%

Đặc điểm đối tượng khảo sát. (Tổng số N = 190)

Nhận xét: Các khoa nội trú và ngoại trú (HSCC; LCK; NTH; NTQ; Nội Nhiễm; Sản; VLTI – PHCN). Cho thấy đối tượng tham gia khảo sát nhận diện chính xác người bệnh >18 tuổi (đạt 98,4%), tỷ lệ giới tính Nữ (55,8 %); Nam (44,2 %)

DỰA VÀO BẢNG KIỂM XÁC NHẬN NGƯỜI BỆNH VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

STT	CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH	CÓ	KHÔNG
I. Xác định đúng người bệnh trước khi thực hiện các kỹ thuật trên người bệnh: Chích FAV, đặt catheter cổ, đùi, chích thuốc, truyền dịch, truyền máu, thay băng, cắt chỉ,...			
1	Tuân thủ nguyên tắc thực hiện 3 kiểm tra, 5 đối chiếu, 5 đúng		
2	Xác định đúng kỹ thuật cần thực hiện		
3	Căn cứ theo hồ sơ bệnh án để thực hiện kỹ thuật.		
4	Nếu thông tin sai sót, thiếu hoặc nhầm lẫn người thực hiện kỹ thuật phải hỏi lại bác sĩ ra y lệnh		
II. Xác định đúng người bệnh trước khi lấy bệnh phẩm xét nghiệm/Cận lâm sàng.			
1	Tuân thủ nguyên tắc thực hiện 3 kiểm tra, 5 đối chiếu, 5 đúng		
2	Đối chiếu thông tin trên giấy xét nghiệm và các chỉ định trong hồ sơ bệnh án/sổ khám bệnh		
3	Đối chiếu thông tin trên mẫu bệnh phẩm với giấy chỉ định CLS		

4	Ghi các thông tin lên ống xét nghiệm trước sự có mặt của người bệnh.		
5	Các thông tin trên giấy và mẫu bệnh phẩm/CLS phải đầy đủ, chính xác, rõ ràng. Nếu chưa chính xác, không rõ ràng như: nhãn xét nghiệm/CLS bị mờ, nhoè chữ phải kiểm tra và thực hiện lại các bước trên; nếu sửa chữa phải có chữ ký xác nhận tên nhân viên y tế khi thực hiện.		
III. Xác định đúng người bệnh trước khi tiến hành thủ thuật, phẫu thuật			
1	Tuân thủ nguyên tắc thực hiện 3 kiểm tra, 5 đối chiếu, 5 đúng		
2	Thực hiện đúng quy trình "Bàn giao người bệnh trước khi tiến hành thủ thuật, phẫu thuật và tiếp nhận người bệnh sau phẫu thuật" Sử dụng bảng kiểm an toàn thủ thuật, phẫu thuật		
IV. Trong quá trình chăm sóc			
1	Luôn đối chiếu trước khi thực hiện		
2	Ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án		
3	Quan sát phản ứng bất thường và báo cáo kịp thời		
V. Sau khi thực hiện dịch vụ			
1	Ghi nhận đầy đủ thời gian, kết quả, chữ ký người thực hiện		
2	Kiểm tra lại tình trạng người bệnh		
3	Báo cáo sự cố (nếu có) theo quy trình		

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC QUY ƯỚC NHƯ SAU:

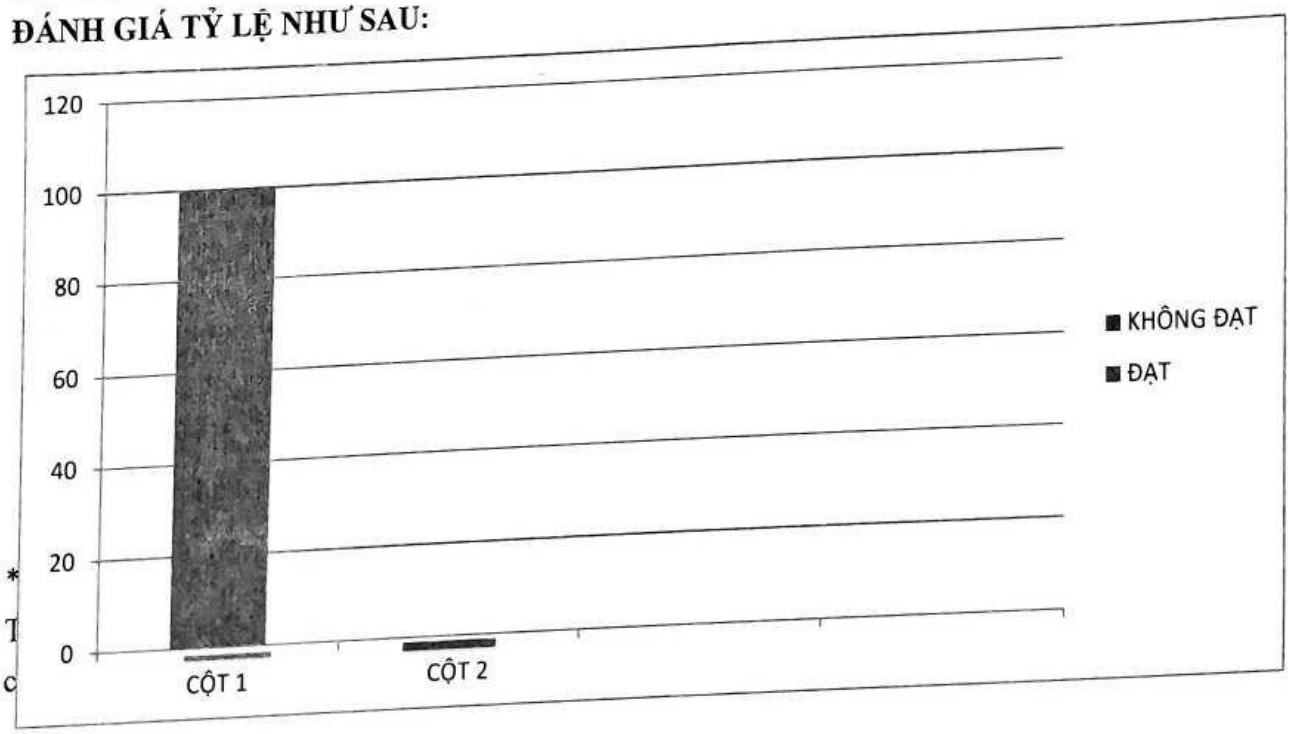
- Có: Đạt
- Không: Chưa đạt

BẢNG CÔNG THỨC TÍNH

Mục tiêu	Đánh giá hoạt động khảo sát nhận diện chính xác người bệnh tại khoa nội trú và ngoại trú của nhân viên y tế
Lĩnh vực áp dụng	Khoa nội tiêu hóa, HSCC; LCK; NTH; NTQ; Nội Nhiễm; Sản; VLTL – PHCN

Phương pháp tính	Từ số (Tổng số phiếu đạt được theo thang điểm đánh giá) ———————————— * 100% Mẫu số (Tổng số phiếu khảo sát)
Tử số	Tổng số phiếu đạt được theo thang điểm đánh giá
Mẫu số	Tổng số phiếu khảo sát
Lý do lựa chọn	Đề án cải tiến chất lượng công tác điều dưỡng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam, mục C6.2
Nguồn số liệu	Bảng kiểm xác nhận người bệnh và dịch vụ cung cấp
Tần suất báo cáo	Năm
Điểm đánh giá	Không => Chưa đạt Có => Đạt

ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ NHƯ SAU:



2. Kết luận

- Cung cấp dịch vụ y tế chính xác không chỉ là tiêu chí nghề nghiệp, mà còn là cam kết đạo đức của ngành y tế đối với cộng đồng.

- Cung cấp dịch vụ y tế an toàn nhằm điều trị hiệu quả cũng như rút gắn thời gian, lẫn chi phí điều trị cho người bệnh, bên cạnh đó còn nâng cao được sự tin tưởng, hài lòng cho người bệnh, thân nhân đối với nhân viên y tế tại các khoa lâm sàng nói riêng, cũng như BV nói chung.

- Nhận diện người bệnh chỉ mất 1 phút, nhưng có thể cứu sống cả một mạng người, vì vậy nhận diện sai người bệnh là một trong những rủi ro, sai sót trong quá trình cung cấp dịch vụ y tế cho người bệnh. Nên mỗi cán bộ nhân viên y tế chúng ta hãy dành một phút nhận diện chính xác, khẳng định chắc chắn người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ y tế. An toàn cho người bệnh và cả nhân viên y tế.

Người báo cáo



Võ Thị Ngọc Nhờ